

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	抽痰 Suction				
編號	A31000-Q05-W-A34	制定者	MI 林詩芳	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.9 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作抽痰技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 除去口鼻與氣管內的分泌物，以維持呼吸道通暢。
2. 避免呼吸道合併症之發生。
3. 採集檢體。

（二）用物準備

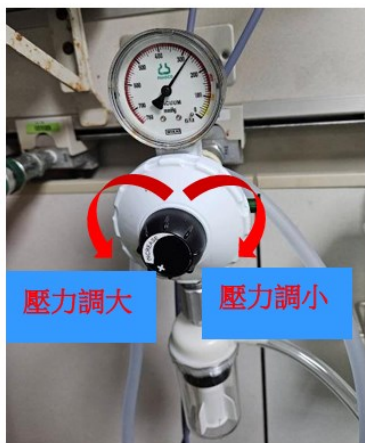
1. 中央抽吸系統或移動式抽痰機。
2. 痰液收集袋 1 個。
3. 外科接管 1 條。
4. 無菌抽痰包內含抽痰管及單隻無菌手套；選擇抽痰管的大小，若經口鼻抽吸者為病人鼻孔的 1/2，經氣管造口處抽吸者為氣管內管的 1/2-2/3 寬，成人使用 10-14 號，小孩 6-8 號。
5. 呼吸擠壓袋(Ambu Bag)（視需要）或給氧裝置。
6. 清潔瓶內裝清水。
7. 聽診器（視需要）。

主題名稱	抽痰	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/8

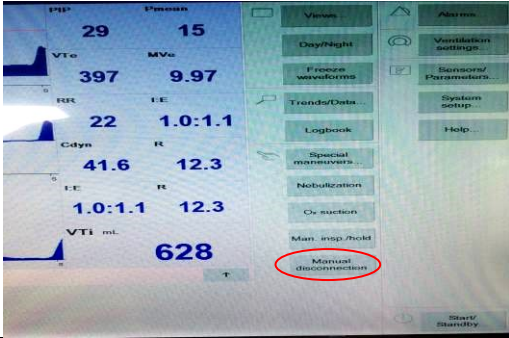


(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對 HIS 系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率／核對狀態，核簽“正確”。	
2. 工作前洗手及準備用物。	
3. 用物攜至病人單位，置用物於適當處。	
4. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋抽痰目的及過程。	確認人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
5. 評估呼吸音。	可利用聽診或胸部 X 光片，協助判定多痰區。
6. 向病人及家屬教導有效深呼吸及咳嗽。	
7. 給予姿位引流及叩擊。	在飯前 1 小時或飯後 2~3 小時或睡前執行，以防噁心、嘔吐及吸入 避免飯前 1 小時或飯後 2 小時
8. 測試抽吸壓力及功能，測試抽痰機並調整適當吸力。	* 成人 120-150 mmHg。 * 小孩 100-120 mmHg。 * 嬰兒 80-100 mmHg。 * 早產兒 60-80 mmHg。



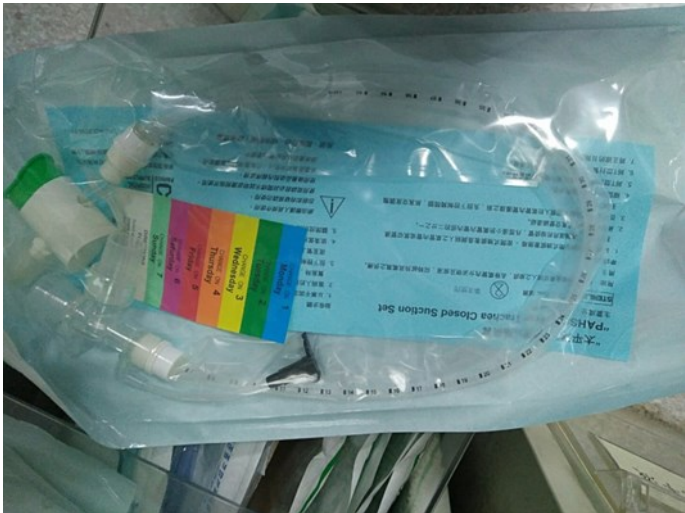
主題名稱	抽痰	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
9. 抽吸前給予病人 100%O₂ 1 分鐘以上或 2 次深呼吸；使用氣管內管或氣管套管，但未使用呼吸器者，以呼吸擠壓袋接 100%氧氣擠壓 4-5 次；使用呼吸器者，可於抽痰前按壓呼吸器(V300、V 500)面板上的「O₂ suction」，並按壓呼吸面板「Manual disconnection」，確認接好無菌抽痰管，即可移開呼吸延長管。 	* 灌食後 1 小時內儘量避免抽痰。 * 嬰幼兒於抽痰後勿立即餵食。 * 按呼吸器「O₂ suction」鍵後可維持 180sec，並給予 100%氧氣，抽痰後接回呼吸延長管即可，如未超過 180sec 即會維持給予 100%氧氣。
10. 打開無菌抽痰包、戴單隻無菌手套。	
11. 手套薄紙置於病人胸前，並將移開後的呼吸延長管放置於手套薄紙上。 	* 呼吸延長管放於手套薄紙上主要避免呼吸延長管口污染。
12. 使用戴上手套的手以無菌方式取出抽痰管並接好外科接管。 	外科接管宜三個月或更換病人時更換一次，或髒時隨時更換。
13. 未戴手套之手控制抽痰管接頭。	
14. 以無菌方式由病人氣管內管或氣切處放入抽痰管至有阻力處再回抽約 1 公分，插入時不按住抽痰管的壓力	

主題名稱	抽痰	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
控制口。	
15. 一手按住控制口，另一手將管子旋轉抽吸。	 手腕作 360 度旋轉抽吸並回抽 按住控制口
16. 回抽時避免以間歇方式開閉控制口。	
17. 每次抽吸時間成人不超過 15 秒，小孩不超過 5-10 秒。	
18. 必要時可重複抽吸步驟直至痰抽淨，先給予 1 分鐘氧氣待病人臉色恢復後再抽吸，每次抽痰間隔 1-2 分鐘。抽吸前後及間隔時間均可視情況給予氧氣，抽吸後鼓勵病人深呼吸 4-5 次，使用氣管內管或氣管套管者可用呼吸擠壓袋擠壓 4-5 次或使用呼吸器者接回呼吸器即可（O ₂ suction 未超過 180 秒時仍會持續給予 100% 氧氣）。	抽痰時注意痰液是否黏稠或有無出血，若有則應注意有無阻塞（突然抽不到痰時應注意內管或套管是否被塞住）。 Blakeman 等人(2022)指引提出不應使用生理食鹽水當作抽痰時常規使用
19. 抽痰順序成人及小兒：氣管內管／氣切套管→鼻→口，新生兒：氣管內管／氣切套管→口→鼻（※因先抽鼻子刺激鼻腔黏膜會反射性地吸入咽喉內的分泌物或抽吸太深刺激迷走神經造成呼吸暫停、心搏過慢）。	如口鼻分泌物太多則先抽口鼻，再更換新的抽痰管抽氣管內管／氣切套管。
20. 抽完痰用清水清潔抽痰管。	抽吸結束後關掉抽吸機器開關，當抽吸瓶或痰液收集袋液面超過 2/3 時應即更換。
21. 抽痰管環狀捲起，手套反摺包住抽痰管丟棄。	抽痰管丟入感染可燃性垃圾袋（桶）。
	
22. 整理病人及病人單位。	需要時可給予口腔護理。
23. 聽診評估呼吸音是否有改變。	
24. 工作後洗手。	
25. 完成 HIS 系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽“已執行”。	
26. 記錄：抽痰時間、痰液之量、性質、顏色、及病人情況。	

主題名稱	抽痰	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/8

步驟	說明
27. 呼吸器使用 High PEEP>10cmH₂O、High FIO₂>60%時則考慮使用密閉式抽痰管(Close suction tube) 	★密閉式抽痰管(Close suction tube)應用於病人身上的目的有：防止痰液噴濺、避免呼吸器供氧中斷，經實證建議應視為呼吸器的一部分，每週更換一次或髒汙破損時即可。 Kuriyama, A., Umakoshi, N., Fujinaga, J., Takada, T. (2015) Impact of closed versus open tracheal suctioning systems for mechanically ventilated adults: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med. 41(3), 402-11. doi: 10.1007/s00134-014-3565-4.

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 林貴滿等(2023)·抽痰法，內外科護理技術（十版，285-290 頁）·台北：華杏

(二) 翁淑娟等合著(2023)·抽痰法，內外科護理技術（十版，285-289 頁）·台北：新文京。

(三) 陳麗敏等合著(2021)·抽痰法，內外科護理技術（六版，184-196 頁）·台北：新文京。

(四) Kuriyama, A., Umakoshi, N., Fujinaga, J., Takada, T. (2015) Impact of closed versus

主題名稱	抽痰	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/8

open tracheal suctioning systems for mechanically ventilated adults: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med. 41(3), 402-11.

<https://doi.org/10.1007/s00134-014-3565-4>

(五) Blakeman, T. C., Scott, J. B., Yoder, M. A., Capellari, E., & Strickland, S. L. (2022).

AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. Respiratory

care, 67(2), 258–271. <https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.4187/respcare.09548>

七、附件

(略)

主題名稱	抽痰	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.01.04	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
99.11.03	2.1	修改說明內容與參考資料。	99 年 11 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.17	3.1	1. 說明(三)步驟及要點說明之 9、11、18、19、21 項內容部份增修。 2. 參考資料更新版本。	103 年 06 月 17 日護理部技術標準委員會通過。
104.03.17	3.2	第三項第(三)目步驟刪除：3%Lysol 清潔抽痰管，改為抽完痰用清水清潔抽痰管。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過。
104.06.18	3.3	第三項第(三)目步驟及要點說明之步驟 1、2 內容更新。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	3.4	1. 修正第三項第(三)目之 4 病人辨識說明。 2. 更新第六項參考資料版本。	105 年 06 月 21 日護理部技術標準委員會通過。
106.06.19	3.5	1. 第三項第(三)目更新部份圖片及說明。 2. 第六項參考資料更新版本。	106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。
107.07.11	3.6	第三項第三目步驟及要點說明：新增第 27 點。	107 年 07 月 11 日護理長會議通過。
108.06.17	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料更新版本。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	抽痰	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.8	1. 第三項第(三)目第 7 點姿位引流注意事項 2. 第三項第(三)目第 8 點抽痰設備 3. 第三項第(三)目第 9 點呼吸器型號及按壓呼吸面板「Manual disconnection」 4. 第三項第(三)目第 12 點外科接管更換時間 5. 第三項第(三)目第 18 點增加治療指引不在抽痰時增加生理食鹽水使用 6. 第三項第(三)目第 27 點密閉式抽痰管更換時機 7. 第六項更新參考文獻	114 年 06 月 16 日技術組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過； 114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。
115.04.07	3.9	第三項第(三)目第 7 點：說明修改為：在飯前 1 小時或飯後 2~3 小時或睡前執行，以防噁心、嘔吐及吸入	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過； 115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。